

Q 45 : – CAT DEVANT UNE INTOXICATION AUX ORGANOPHOSPHORES

INTRODUCTION :

- Intoxication fréquente due à des pesticides : puissant inhibiteur d'acétylcholinestérase => accumulation d'acétylcholine.
- Se manifeste par syndrome muscarinique, nicotinique et central.
- Traitement symptomatique et spécifique.

DIAGNOSTIC :

A- Interrogatoire :

- Intoxiqué : âge, profession, tares
- Toxique : nature (car TT spécifique possible), quantité
- Intoxication : Heure, Circonstances (professionnel, accidentel, volontaire), Voies de pénétration (ingestion+++ , cutanée, inhalation)

B- Tableau clinique :

Intervalle libre : quelques minutes à quelques heures en fonction du produit et dose ingérée/inhalée.

Phase de début : signes digestifs+++ (douleur, nausées, vomissements, brûlures gastriques).

Phase d'état : 3 syndromes (souvent consultation à ce stade)

1-Syndrome muscarinique : stimulation parasympathique post-ganglionnaire :

- . Signes d'hypersécrétion : salivaire, sudorale, bronchique, diarrhée...
- . Action sur muscles lisses : myosis serré punctiforme, bronchoconstriction, N/V, péristaltisme, miction et défécation involontaires....
- . Action cardiaque (plus marqué si cardiopathie associée) : bradycardie, hypotension, trouble de rythme et de conduction, AC.

→ **Hypersécrétion + myosis serré + bradycardie = intoxication par OP jusqu'à preuve du contraire**

2-Syndrome nicotinique : fatigabilité, fasciculations, crampes, paralysie musculaire (respiratoire => détresse++).

3-Syndrome central : céphalées, troubles du comportement, coma, convulsions, troubles neurovégétatifs...

C- Paraclinique : → **intérêt médico-légal+++ : législation du dossier et confirmer l'atteinte professionnelle.**

- Dosage de l'activité cholinestérasique dans le plasma :
- Dosage pseudo-cholinestérasas plasmatiques (PCP).
- Dosage d'acétylcholinestérase globulaire (ACG)
 - Prélèvement : 10 ml tube hépariné réfrigéré envoyé au labo de toxico
 - Taux se normalise 2-3 mois plus tard (PEC en urgence = clinique et traitement, prélèvement se fait après+ normal permet d'éliminer le Dc)
 - . Taux <50%: signes cliniques
- Dosage paranitrophérol (Parathion, méthylparathion...).
- Recherche toxicologique (liquide gastrique, sang, urines) n'est plus utilisé.

TRAITEMENT :

A-Hospitalisation en réanimation + MEC : VVP de bon calibre ; sonde gastrique , monitoring continu de l'ECG + Bilan initial

B- Traitement symptomatique :

- Maintien des fonctions vitales (respiratoires, circulatoires, neurologiques et thermiques)
- Barbituriques, Benzodiazépine, ... en cas de convulsions (Diazépam 0,5mg/kg (<20kg) ou 10mg (>20kg)).

C- Traitement évacuateur :

- Décontamination cutanée (deshabiller + laver) et oculaire (lavage oculaire abondant) : le plutôt.
- Lavage gastrique : quel que soit délai, respect des CI (coma, produits caustiques, hydrocarbures pétroliers...)
- Charbon activé : 25-50mg puis demi-dose par 4h (la plupart des antidotes sont par voie IV et donc ne risquent pas d'être non absorbés).

D- Traitement spécifique :

On donne le pralidoxime en 1^{ère} intention si disponible, sinon commencer par l'atropine

- **Atropine :**
 - . Correction des effets muscariniques : 2mg/5-10 min en IV jusqu'à signes d'atropinisation (tachycardie, peau sèche, régression de myosis...),
 - . Puis 0,02-0,08mg/kg/h en perfusion continue pendant 24h.
- **Pralidoxime : Contrathion[®] :**
 - . Régénérateur spécifique des cholinestérasas => correction des effets muscariniques et nicotiniques.
 - . 200–400 mg diluées dans SS iso à passer en 30min, renouveler toutes les 4-6h pendant 24-48h

E- Surveillance et évolution :

- En milieu de réanimation (état de conscience, état hémodynamique, état respiratoire, examen clinique, GDS).
- Évolution favorable sur 1 semaine ou plus
- Syndrome intermédiaire (pas fréquent) : atteinte neuromusculaire par libération d'OP stockés 1-4 jours d'intervalle libre.
 - Nécessité d'une surveillance prolongée d'au moins 4 jours, de toute intoxication organophosphorée
- Séquelles possibles : neuropathies (rares, fatigues musculaires)

F- PEC psychiatrique+++

CONCLUSION :

- Intoxication fréquente et grave.
- Intérêt de la prévention+++ : information des utilisateurs, manipulation soigneuse.